

ID Paciente: P005

NHC: NHC-2022-012089

Generado: 09/04/2026

HISTORIA CLÍNICA INTEGRADA

1. Datos del paciente

Nombre completo	Esperança Tormos Vidal
Sexo	Mujer
Fecha de nacimiento	22/09/1965 (59 años)
DNI	73.561.802-R
Teléfono	964 558 221
Municipio	Almassora
Médico responsable	Dr. Pablo Iranzo Climent
Especialidad	Reumatología

2. Antecedentes personales

- Artritis reumatoide seropositiva (FR+ y anti-CCP+) — diagnóstico 2019
- Osteoporosis secundaria a corticoterapia crónica
- Fibromialgia concomitante (diagnóstico diferencial en revisión)
- Hipertensión arterial en tratamiento monoterapia
- Depresión reactiva en seguimiento psiquiatría
- Sin alergias medicamentosas conocidas

Antecedentes familiares: Madre: artritis reumatoide. Hermana: lupus eritematoso sistémico.

3. Historia clínica

Paciente de 59 años con artritis reumatoide de 6 años de evolución, actualmente en tratamiento combinado con metotrexato y adalimumab. En las últimas 8 semanas refiere brote articular con tumefacción y dolor en muñecas, MCF 2ª y 3ª bilaterales y tobillo derecho. Rigidez matutina > 60 minutos. DAS28-PCR en la consulta: 4,8 (actividad moderada-alta). Niega fiebre, escalofríos ni síntomas infecciosos recientes. Última dosis de adalimumab hace 14 días. Cumplimiento farmacológico correcto.

4. Exploración física

Peso / Talla / IMC	67 kg · 163 cm · 25,2 kg/m²
Tensión arterial	128/78 mmHg
Frecuencia cardíaca	74 lpm
Temperatura	36,9 °C
Saturación O2	98 % (aire ambiente)

Articular	Tumefacción sinovial en MCF 2-3 bilateral. Tobillo derecho: calor y derrame articular leve. Fuerza presión manual disminuida bilateralmente
Auscultación cardíaca	Tonos rítmicos, sin soplos
Auscultación pulmonar	Sin hallazgos
Piel	Sin rash. No nódulos reumatoides visibles
DAS28-PCR	4,8 — actividad moderada-alta

■ 5. Tratamiento farmacológico actual

Medicamento	Posología
Metotrexato 20 mg	Subcutáneo semanal (lunes) + ácido fólico 5 mg el martes
Adalimumab 40 mg	Subcutáneo cada 14 días
Prednisona 5 mg	1 comp. en desayuno (dosis mínima mantenimiento)
Omeprazol 20 mg	1 comp. en ayunas (gastroprotección)
Alendronato 70 mg	1 comp. semanal (lunes en ayunas, antes del MTX)
Calcio + Vitamina D	1 comp. en comida
Enalapril 10 mg	1 comp. en desayuno
Duloxetina 60 mg	1 comp. en desayuno

■ 6. Nota de seguimiento — 25/02/2025

Motivo de consulta	Revisión reumatología — brote articular en curso
--------------------	--

Subjetivo (anamnesis):

La paciente acude con escasa movilidad de manos. Refiere empeoramiento progresivo en las últimas 8 semanas. Dolor EVA 7/10 en reposo y 9/10 con movimiento. Rigidez matutina de 90 minutos. Dificultad para realizar actividades básicas (abrocharse ropa, cocinar). Sueño perturbado por el dolor. Niega infecciones recientes, cuadro catarral ni fiebre. Refiere tristeza y desmotivación relacionada con la limitación funcional.

Objetivo (datos clínicos):

DAS28-PCR: 4,8. PCR 38 mg/L (previa 12 mg/L). VSG 72 mm/h. Radiografía manos: erosiones leves en MCF 3ª derecha estables respecto a 2023. Sin infiltrados pulmonares en Rx tórax.

Plan terapéutico:

- Brote moderado-alto. Pauta de corticoides puente: prednisona 20 mg/día durante 2 semanas con reducción progresiva a 5 mg en 6 semanas.
- Mantener adalimumab. Valorar cambio a biológico de mecanismo diferente (tocilizumab, abatacept) si no respuesta en 3 meses.
- Solicitar eco musculoesquelética de muñecas y tobillo derecho para cuantificar sinovitis.
- Fisioterapia: derivar a programa de rehabilitación funcional manos.
- Control analítico en 6 semanas (hemograma, transaminasas, PCR, VSG).
- Valorar ajuste duloxetina con psiquiatría por deterioro del estado de ánimo.
- Próxima revisión en 6 semanas.

■ 7. Resultados de laboratorio — 22/02/2025

Parámetro	Resultado	Referencia	Flag	Unidades
PCR	38	< 5	H	mg/L
VSG (1h)	72	< 20	H	mm/h
FR (Factor Reum.)	148	< 14	H	UI/mL
Anti-CCP	320	< 10	H	U/mL
Hemoglobina	10,6	12,0 – 16,0	H	g/dL
VCM	82	80 – 100	N	fL
Leucocitos	8,2	4,0 – 11,0	N	x10 ³ /μL
Plaquetas	412	150 – 400	H	x10 ³ /μL
ALT (GPT)	28	< 40	N	U/L
AST (GOT)	24	< 40	N	U/L
Creatinina	0,78	0,50 – 1,10	N	mg/dL
Vitamina D (25OH)	18	30 – 100	L	ng/mL
Calcio total	9,1	8,5 – 10,5	N	mg/dL
ANA (IF)	Neg.	Negativo	N	—

Observaciones: Brote activo confirmado: PCR 38 mg/L y VSG 72 mm/h con DAS28 4,8. Anemia leve normocítica compatible con anemia de enfermedad crónica. Déficit de vitamina D: iniciar suplementación con colecalciferol 2.000 UI/día. Trombocitosis reactiva a inflamación activa, sin significado clínico independiente.

Documento de uso exclusivo para investigación. Todos los datos son ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de información biomédica y clínica.